

AERIS | Leitfaden: Digitale Dokumentation & Hardware im Mehrpersonen-Team

Rechtliche, organisatorische und technische Standards für freiberufliche Intensivpflegekräfte im 24/7-Schichtwechsel (§ 29 SGB IX / § 132i SGB V)

Szenario: Versorgen mehrere voneinander unabhängige, freiberufliche Pflegefachkräfte (Einzelunternehmer) denselben 1:1-Intensivklienten im Persönlichen Budget, gilt das eiserne Prinzip: **Eine gemeinsame digitale Patientenakte vor Ort zur Patientensicherheit, aber strikt getrennte abrechnungsrelevante Systeme je Leistungserbringer.**

1. Grundprinzip: Klienten-Akte vs. Einzelunternehmer-Abrechnung

In der 1:1-Intensivpflege verlangt das Haftungs- und Sozialrecht (GKV-Spitzenverband, Medizinischer Dienst) eine lückenlose, fortlaufende Dokumentation am Ort der Leistungserbringung (in der Häuslichkeit des Klienten). Hierbei wird strikt zwischen zwei Dokumentationsebenen unterschlagen:

Dokumentationsebene	Inhalte & Instrumente	Führung & Speicherort	Rechtliche Vorgabe
Klientenbezogene Patientenakte (Gemeinsame Doku)	• SiS® & Stammdaten • Individueller Maßnahmenplan • Vitalwerte, BGA, Beatmung • Wund- & Schmerzprotokolle • Täglicher Schichtbericht	EINE Akte vor Ort im Intensivpflege-Zimmer des Klienten. Alle Pflegenden tragen schichtweise ein.	MD-Prüfkriterien (QPR), Patientensicherheit, Notfallkette & nahtlose Schichtübergabe.
Pflegekraftbezogene Abrechnung (Einzeldokumente)	• Eigener Dienstleistungsvertrag • Monats-Rechnungen (§ 14 UStG) • Stundennachweise (Abtretung) • Ausfallnachweis (§ 615 BGB)	STRIKT GETRENNT im eigenen Buchhaltungs- / EDV-System jedes Freiberuflers.	Finanzamt-Vorgaben, GoBD, Statusfeststellung (§ 7a SGB IV) & Urheberrecht.

2. Wer stellt das Medium (Hardware / Device) bereit?

Für die Bereitstellung des digitalen Eingabemediums (Tablet/PC) haben sich im Persönlichen Budget drei praxiserprobte Modelle etabliert:

Modell 1: Das Klienten-Device vor Ort (Der Königsweg / Standard)

Ablauf: Der Klient (Budgetnehmer) stellt ein fest installiertes Tablet (z. B. iPad) im Intensivzimmer bereit. Darauf läuft die Dokumentations-Web-App (z. B. AERIS / Clariva / CareInsight).

- **Datenschutz (Art. 9 DSGVO):** Keine sensiblen Patientendaten auf privaten Geräten der Pflegekräfte.
- **Übergabe-Sicherheit:** Gerät verbleibt am Bett; jede Schicht meldet sich mit eigenem PIN/Login an.
- **Refinanzierung:** Die Hardware-Anschaffung kann als Organisationsmittel/Hilfsmittel im Budget gegenüber der Kasse abgerechnet werden.

Modell 2: Bring Your Own Device (BYOD) mit Local-First & P2P-Sync

Ablauf: Jede Pflegekraft bringt ihr eigenes Dienst-Tablet mit.

- **Anforderung:** Die Software nutzt eine *Local-First-Architektur* mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (AES-256).
- **Sicherheit:** Nach Schichtende und Logout verbleiben keinerlei unverschlüsselte Klientendaten auf dem Gerät.

Modell 3: Kombiniertes Account-Modell (LISA-Digital / Clariva Standard)

Ablauf: Der Stamm-Account liegt beim Klienten. Alle tätigen Freiberufler erhalten individualisierte Benutzer-Zugänge (Pins/Tokens) für den schichtweisen Eintrag.

3. Rechtliche Einordnung: Scheinselbstständigkeit & Datenschutz

WICHTIGER RECHTSHINWEIS: Die gemeinsame Nutzung des Klienten-Tablets oder der Pflegedoku-Software vor Ort begründet **KEINE Scheinselbstständigkeit (§ 7a SGB IV)**. Die Pflicht zur gemeinsamen Dokumentation dient ausschließlich der Patientensicherheit und entspricht den rechtlichen Vorgaben zur Behandlungs- und Notfallversorgung.

- **Keine Eingliederung in fremde Betriebe:** Freiberufler nutzen das Doku-System des Klienten (Patientenakte), nicht das System eines Pflegedienstes oder Konkurrenten.
- **Datenschutz (Art. 9 DSGVO & § 203 StGB):** Durch den Behandlungsvertrag und die schriftliche Schweigepflichtentbindung des Klienten sind alle im Team tätigen Fachkräfte berechtigt, Einsicht in die Doku zu nehmen und Einträge vorzunehmen.

4. Schichtwechsel-Protokoll & Digitale Gegenzeichnung

Prozess-Schritt	Verantwortlichkeit	Durchführung & Doku-Standard
1. Dienstübernahme & Vital-Check	Eingehende Pflegefachkraft	Abgleich aller Soll-Parameter (Beatmung, Cuffdruck, BGA), Funktionskontrolle Notfall-Set (Ambu-Bag, Ersatzkanüle) & Eintrag im Schichtprotokoll.
2. Verlaufs- & Pflegedokumentation	Diensthabende Pflegefachkraft	Echtzeit-Eintrag aller Behandlungspflege- (SGB V) und Grundpflege-Leistungen (SGB XI), Schmerz-Assessments (BESD) & Wundstatus.
3. Schichtende & Versiegelung	Gehende Pflegefachkraft	Digitaler Abschluss des Schichtberichts mit Zeitstempel & PIN-Handzeichen. Revisionssichere Sperrung gegen nachträgliche Manipulation.
4. Monats-Freigabe & Abtretung	Klient / Betreuer & Pflegekraft	Digitale Gegenzeichnung des Monats-Leistungsnachweises auf dem Tablet zur direkten Einreichung bei der Krankenkasse.

Formelle Bestätigung der Dokumentations- und Übergabestandards:

René Krieg
Pflegefachmann / AERIS Inhaber

Klient / Gesetzlicher Vertreter
Budgetnehmer (§ 29 SGB IX)